

Hib (Act-Hib, Hiberix): Συζευγμένο εμβόλιο κατά του Αιμόφιλου ινφλουέντσας τύπου β. Παρασκευάζεται από κεκαθαρισμένο πολυσακχαρίτη του περιβλήματος στελέχους Αιμοφίλου ινφλουέντσας Β, συνδεδεμένου με την πρωτεΐνη Diphtheria CRM197 ή με πρωτεΐνη τετάνου.

- * Προφύλαξη από λοιμώξεις από *H. influenzae B*, παιδιών ηλικίας 2 μηνών μέχρι 5 ετών.
- * Το εμβόλιο του *H. influenzae B* δεν προστατεύει έναντι άλλων οροτύπων εκτός του Β.
- * Παιδιά < 6 μηνών: 3 δόσεις με μεσοδιάστημα 2 μηνών. Αναμνηστική δόση > 12-15 μηνών.
- * Παιδιά 7-12 μηνών: 2 δόσεις και αναμνηστική δόση σε ηλικία > 15 μηνών.
- * Παιδιά 12 μηνών - 5 ετών: μία μόνο δόση.

Στην Ελλάδα σήμερα διατίθενται τρία εμβόλια για τον αιμόφιλο. Το Act-Hib και το Hiberix (συνδεδεμένα με τοξοειδές τετάνου) και το Hib-TITER (συνδεδεμένο με διφθεριτική τοξίνη).

Η αντισωματική απάντηση και των τριών εμβολίων είναι ικανοποιητική (παραγωγή επαρκούς τίτλου αντισωμάτων σε ποσοστό > 90%).

Το εμβόλιο του Αιμόφιλου, μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με άλλα εμβόλια (DTP, MMR, Sabin, ηπατίτιδας Β), αλλά πρέπει να επιλεγεί άλλο σημείο εμβολιασμού. Ο εμβολιασμός δεν είναι απαραίτητο να συνεχίζεται με το ιδιοσκεύασμα της ίδιας εταιρείας.

Τα εμβόλια του Αιμόφιλου δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες παρενέργειες. Προκαλούν ήπιες τοπικές αντιδράσεις, όπως πόνο, ερυθρότητα και οίδημα στο σημείο της ένεσης σε ποσοστό μέχρι και 25% των εμβολιαζόμενων, που υποχωρούν σε 12-24 ώρες, ενώ συστηματικές αντιδράσεις όπως πυρετός και ανησυχία παρατηρούνται σχετικά σπάνια.

MCC (Meningitec): Συζευγμένο, πολυσακχαριδικό εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου της οροομάδας C (μονοδύναμο). Παρασκευάζεται από πολυσακχαρίτες του περιβλήματος της *N. meningitidis*. Το διδύναμο εμβόλιο περιέχει 50 μg από το πολυσακχαριδικό αντιγόνο των οροομάδων A και C και το τετραδύναμο των οροομάδων A, C, Y και W135 (MCV4).

- * Ενδείξεις χορήγησης:
 1. Προφύλαξη από μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη σε περίπτωση επιδημίας, ειδικά από τις οροομάδες A και C που περιλαμβάνονται στο εμβόλιο.
 2. Σε άτομα που πρόκειται να ταξιδέψουν σε αναπτυσσόμενες χώρες (ενδημική ζώνη).
 3. Σε ασθενείς με ανατομική ή λειτουργική ασπληνία.
 4. Σε ασθενείς με έλλειψη κλασμάτων του συμπληρώματος.
 5. Δεν συνιστάται για μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού.
- * Συνιστάται η έναρξη του εμβολιασμού σε ηλικία 2 μηνών και ακολουθεί σχήμα 3 δόσεων: οι 2 πρώτες δόσεις με μεσοδιάστημα 2 μηνών και η επαναληπτική σε ηλικία 15-18 μηνών.
- * Σε περίπτωση έναρξης εμβολιασμού σε ηλικία > 12 μηνών, ακολουθείται σχήμα 1 δόσης.
- * Στην Ελλάδα κυκλοφορούν σήμερα δύο συνδεδεμένα εμβόλια, κατά του οροτύπου C.
 - I. Το πρώτο που κυκλοφόρησε, ονομάζεται **Meningitec**, είναι συζευγμένο μονοδύναμο με περίπου 15 μg της πρωτεΐνης CRM197 του κορυνοβακτηριδίου της διφθερίτιδας και χορηγείται όπως αναφέρθηκε από την ηλικία των δύο μηνών.
Το εμβόλιο Meningitec, σε βρέφη ηλικίας < 12 μηνών, χορηγείται σε 3 δόσεις, με μεσοδιάστημα τουλάχιστον ενός μηνός η μία από την άλλη.
 - II. Το άλλο εμβόλιο ονομάζεται **Neisvac-C**, είναι συνδεδεμένο με τετανική ανατοξίνη και χορηγείται σε 2 δόσεις σε βρέφη 2-4 μηνών, με ελάχιστο μεσοδιάστημα 2 μηνών. Βρέφη άνω των 4 μηνών, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες εμβολιάζονται με μία δόση.

Πρόσφατα εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού και το 4δύναμο εμβόλιο κατά του ορότυπου B (**Bexsero**). Στα βρέφη γίνονται 3 δόσεις ξεκινώντας από 2 μηνών, με μια επαναληπτική μετά έτος. Στα βρέφη 6-12 μηνών γίνονται 2 δόσεις και μια επαναληπτική μετά από ένα έτος. Στα βρέφη 1-2 ετών γίνονται 2 δόσεις και μια επαναληπτική μετά τα δύο. Σε παιδιά άνω των 2 ετών γίνονται 2 δόσεις, με απόσταση 2 μηνών μεταξύ τους.